

质量部詹吉生 11 月份

工作量汇报

(一) 11 月工作日报

- 1) 准备周例会材料
- 2) 2、常州七院选择项审核（未完）
- 3) 3、新乡中心医院五级开会指导现场截图
- 4) 4、周例会汇报
- 5) 1、惠山二院基本项审核完成，问题意见提交共享文档，后续王凯对接
- 6) 2、惠山二院、东海历史数据迁移流程方案讨论会议。具体流程：1、测试抽取 8 个病人（项目现场），2、使用校验脚本校验（薛建，刘频洲下周三完成校验脚本），3、如果成功，继续抽取大批量数据（标准要求前个厂商，至少 5 年数据）。如果失败，退回；4、批量校验，制作完工文档（模版崔毅）；5、质量部对接负责人远程验证 5 个病人，至少 4 个病人通过验证，项目验收成功，否则退回工程部
- 7) 孝感妇幼互联互通现场定性审核
- 8) 1. 东方医院互联互通张旭模拟问题安排周三讨论
- 9) 2. 月度会会议纪要和单总沟通修改，质量部分工安排
- 10) 3. 施君，王毅一起讨论济南中心医院，鹤壁市人民医院智慧服务问题
- 11) 4. 孝感妇幼互联互通迎检人员培训脚本书写和培训
- 12) 1、早上制作质量部月度会汇报材料
- 13) 2、下午公司月度会
- 14) 1. 上午孝感妇幼安排会场，人员模拟计划
- 15) 2. 下午孝感妇幼江院，信息科，全体迎检人员一起动员会
- 16) 3. 二三会场模拟培训
- 17) 1. 出差去孝感妇幼互联互通现场定性审核，下午 3 点到
- 18) 2. 3.30 到医院，和江院长，魏主任商量会场布置，人员安排。
- 19) 1、惠山二院五级基本项审核（未完）
- 20) 2、协调宝鸡、孝感现场审核的人员和准备等事项
- 21) 1、互联互通定性审核准备工作讨论和人员安排（宝鸡 23 号定量-郁佳伟、王凯、孝感 25 号远程定性-詹吉生）
- 22) 2、孝感互联互通远程定性审核和现场、医院商量准备事项
- 23) 3、惠山二院电子病历五级基本项审核（未完）
- 24) 4、质量部 26 年工作计划讨论制定。
- 25) 1、部门周会
- 26) 2、惠山二院基本项审核（未完成）
- 27) 3、宝鸡互联互通现场审核协调——现场消息 23 号，周五支援人员到场
- 28) 东海医院五级基本项审核完，问题已经反馈现场
- 29) 东海医院基本项审核(未完成)
- 30) 1、孝感妇幼互联互通定性培训（门诊挂号收费、住院收费、检查（放射、

超声)、检验、护士、医务科、门诊药房发药、住院药房发药、处方点评药师)。

- 31) 2、孝感妇幼信息科、现场开会确定互联互通定性迎检分工。
- 32) 11.7 日
- 33) 1. 早上和范院长，信息科刘副主任，岳鹏飞，药剂科陈老师，医务科郭老师，现场王海鹏，一起开会讨论目前五级工作截图和功能应用方面存在问题和解决方案。医院计划召开启动会，配合医务准备会议材料。
- 34) 2. 下午公司开复盘会。
- 35) 1、湖州三院选择项审核完成，提交詹科
- 36) 2、济南中心医院智慧服务远程会诊系统和转诊系统，无法推进，和现场肖庆华、王毅沟通协调
- 37) 3、东方医院互联互通定性培训

(二) 11 月份工作量统计分析 (豆包统计)

一、任务总量与覆盖范围：多线并行，覆盖核心业务全流程

1. **任务数量统计：**日报中明确记录的独立任务共 28 项 (不含子流程)，其中已完成 11 项、未完成 / 进行中 17 项，完成率约 39.3%，未完成任务多为跨周期攻坚项。

2. 业务覆盖维度：

- 核心审核类：电子病历五级基本项 / 选择项审核 (惠山二院、东海医院、湖州三院、常州七院等 6 家医院)，涵盖 “基本项 + 选择项” 全类型审核，符合医院智慧服务分级评估的核心要求；
- 项目推进类：数据迁移流程设计、互联互通定性审核 (孝感、宝鸡、东方医院等)、智慧服务系统协调 (济南中心医院等)，涉及数据校验、培训、会场筹备等全流程；
- 会议与材料类：周例会 / 月度会材料准备、汇报、会议纪要修改、26 年工作计划制定等 6 项，占比约 21.4%；
- 协作协调类：人员调度、跨部门分工、医院端对接 (院长、信息科、医务科等)，涉及内外部协作场景 12 次。

二、任务复杂度：高难度攻坚任务占比高，技术与沟通双重挑战

1. 高复杂度任务突出：

- 攻坚类：惠山二院、东海医院五级审核 (跨周期未完成)、济南中心医院智慧服务系统推进受阻协调，需解决技术卡点与资源适配问题；
- 流程设计类：惠山二院 + 东海医院历史数据迁移流程 (含 5 个子步骤，涉及测试抽取、脚本开发、批量校验、验收验证等多环节)，需统筹多方资源按节点推进；

- 定制化服务类：孝感妇幼互联互通培训（覆盖 9 个核心科室）、迎检分工制定、会场布置，需适配医院个性化需求，协调成本高。

2. 低复杂度任务占比低：仅“湖州三院选择项审核完成”“新乡中心医院截图收集”等 3 项为单一流程任务，占比不足 11%，其余均需多步骤推进或跨角色协作。

三、协作强度：内外部联动频繁，跨角色跨部门协同密集

1. 内部协作：涉及薛建、刘频洲、王凯、詹吉生等 10+ 同事，协作场景包括脚本开发、人员支援调度、任务交接（如审核结果提交、后续对接），符合多维度资源协同的工作分配逻辑；
2. 外部对接：与 6 家医院的院长、信息科主任、医务科、药剂科等多科室负责人沟通 15 次，涉及问题研讨、方案确定、会议筹备等关键环节，沟通成本高且需精准对接需求；
3. 会议协作：累计参与 / 组织内外部会议 10 次（含医院现场会、公司复盘会、分工协调会），平均每 3 天 1 场核心会议，且需同步输出材料或跟进落实事项。

四、工作量负荷特征：高饱和、高压、跨周期延续性强

1. 时间密度：单日最高承载任务 4 项（如“制作月度会材料 + 公司月度会 + 孝感会场安排 + 动员会”），无空白工作日，任务排布紧凑；
2. 压力来源：
 - deadline 驱动：宝鸡 23 号定量审核、孝感 25 号远程定性审核等明确时间节点任务，需提前完成人员、材料、培训全筹备；
 - 不确定性挑战：济南中心医院系统推进受阻、审核中发现的功能应用问题，需临时协调解决方案，增加额外工作量；
3. 任务延续性：惠山二院五级审核、孝感妇幼迎检准备等任务跨多日推进（最长延续超 1 周），需持续跟进，无法快速闭环。

五、核心结论与 workload 评估

1. 整体负荷等级：★★★★★（高负荷），符合高复杂度项目场景下的脑力负荷特征，主要体现在“任务并行度高 + 协作链路长 + 攻坚任务多”；

2. 未完成任务原因：非效率问题，而是任务本身跨周期（如数据迁移需等待脚本开发）、跨部门依赖（如质量部验收、医院启动会筹备）、资源协调难度大导致；
3. 工作价值导向：任务集中于医院分级评估、互联互通等核心业务，直接关联智慧医疗建设核心目标，兼具“执行落地”与“策略规划”属性（如 26 年工作计划制定）。